

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



**Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva en
madres que acuden a un Centro de Salud, Lima - 2024**

Proyecto de Tesis:

Para optar al título profesional de Licenciada en Enfermería

AUTORA

Rodriguez Vela Sol Venus

ASESORA

Dra. Nancy Huamán Salazar

LIMA - PERÚ

2024

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción.....	3
1.2. Planteamiento del problema	4
Determinación del problema	4
Formulación del problema	8
1.3. Objetivos	8
1.4. Importancia y alcance de la investigación	9
1.5. Limitaciones de la investigación	10

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Antecedentes del estudio	10
2.2. Bases teóricas	15
2.3. Definición operacional de términos	27

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis	27
3.2. Variables (identificación de variables)	27
3.3. Operacionalización de variables	28

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Tipo y método de investigación	28
4.2. Diseño de investigación.....	29
4.3. Sede de estudio.....	29
4.4. Población, muestra y muestreo (criterios de inclusión y exclusión)	29
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad...	30
4.6. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos	31
4.7. Análisis estadístico	32
4.8. Consideraciones éticas	32

V. ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1. Cronograma de Grant	33
5.2. Presupuesto	34
5.3. Recursos	34

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
----------------------------------	----

ANEXOS	43
--------------	----

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

La lactancia materna es tan antigua como lo es la humanidad, y los beneficios que conlleva se han ido descubriendo a lo largo de los años. Por ello, es importante el papel que una mujer cumple mediante la lactancia materna, ya que desde miles de años atrás se ha ido convirtiendo en un medio de supervivencia, pues la madre se convierte en el único ser que brinda alimento de subsistencia nutricional a los lactantes.⁽¹⁾

En este aspecto, la sociedad debe brindar su apoyo a las madres constantemente para fomentar la lactancia materna, debido a su gran importancia al realizarla y como consecuencia prolongarla en las futuras generaciones, disminuyendo los declives de brindar lactancia materna exclusiva. Por lo cual, el personal de enfermería es un sujeto fundamental en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna exclusiva, ya que se encarga de educar a las madres y a su vez concientizar sobre la importancia de ponerlo en práctica. Por lo que es necesario realizar el presente estudio titulado “Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden a un Centro de Salud, Lima - 2023”, con el propósito de que, a partir de los resultados obtenidos, se pueda proporcionar una información actualizada a las autoridades de dicha institución de salud, con la finalidad de que puedan implementar estrategias que orienten a la promoción de la lactancia materna exclusiva.

El estudio está dividido en cinco capítulos: Capítulo I: Introducción, que incluye el planteamiento del problema y su formulación respectiva, objetivos, justificación y limitación; capítulo II: Revisión de la literatura, aquí se encuentran los antecedentes, bases teóricas, definición operacional de términos; capítulo III: Hipótesis y variables, la cual abarca identificación y operacionalización de las variables; capítulo IV: Materiales y métodos, que expone el tipo, método y diseño de investigación, sede de estudio y población, técnica e instrumento de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos, análisis estadístico

y consideraciones éticas; capítulo V: Cronograma de Grant, presupuesto y recursos. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y anexos.

1.2. Planteamiento del problema

Desde hace algunas décadas, existe un interés especial por la salud de los niños y las condicionantes que la alteran, debido a las diferentes enfermedades que pueden contraer o padecer desde su nacimiento; el recién nacido no tiene la facilidad de digerir otro tipo de alimento que no sea la leche materna ⁽²⁾; ya que esta, cubre sus requerimientos nutricionales; fortaleciendo su sistema inmune, y protegiéndolo de diversas enfermedades como gastrointestinales, respiratorias, entre otras ⁽²⁾. Por tal motivo, la lactancia materna es un indicador muy importante que refleja el nivel de bienestar de una sociedad en su conjunto ⁽³⁾.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽⁴⁾ refiere que casi el 50% de todas las muertes en niños es por causa de la desnutrición, y destaca que esto se debe a que la alimentación en los primeros meses de vida no ha sido la adecuada; por ello, en unión con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recomiendan que la lactancia materna debe iniciarse en la primera hora de vida del bebé, y que deben ser amamantado de forma obligatoria el primer semestre de vida.

De esta manera, el bebé podrá prevenir enfermedades no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad; y a la madre, la beneficia en que la involución uterina se genere con mayor rapidez y también a disminuir el riesgo de contraer cáncer mamario ⁽⁵⁾.

Según la UNICEF, en América Latina y el Caribe, este 2023, el 57% de los bebés no recibe leche materna exclusiva, esto se da mayormente en madres que deben salir a trabajar, y en sus centros laborales, no siempre cuentan con un espacio establecido como un lactario que les permita fortalecer la lactancia materna exclusiva (LME), por eso, la gran mayoría de madres debe escoger entre trabajar o amamantar, dejando de lado o en segundo plano la práctica de lactancia materna ⁽⁶⁾.

En el Perú ⁽⁷⁾, las cifras de niños que reciben leche materna durante su primera hora de vida, han ido disminuyendo con el paso de los años, ya que en el 2021 casi el 50% la recibían; sin embargo, en el 2022 solo hasta casi el 46%. Por lo que actualmente, más del 50% se queda sin recibir leche materna en su primera hora de vida. Además, el 34.1% no recibe lactancia materna de forma exclusiva en nuestro país, siendo las zonas urbanas en donde menos se pone en práctica (61.4%), a diferencia de las zonas rurales (76.7%), todo esto ocurre porque la mayoría de las madres que cuentan con estudios superiores prefieren optar por fórmulas lácteas a diferencia de las que no tienen educación o solo han terminado su primaria ⁽⁸⁾.

Según las cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022, la proporción de niñas y niños menores de seis meses de edad que recibieron lactancia materna exclusiva a nivel nacional, aumentó de 64% a 65.9% entre el 2021 y 2022. Según regiones, la Sierra y la Selva presentan mejores cifras en comparación que la Costa, ya que ambas regiones tienen 77.5% y 69.7%, respectivamente. Según la educación, las madres que no cuentan con educación o que solo han terminado la primaria son las que brindar mayor lactancia materna llegando a casi el 79%. Y según los departamentos del Perú, y haciendo una comparación entre el año 2017 y el 2022, se evidencia que los mayores porcentajes en el 2017 fueron Ayacucho, Apurímac y Puno; mientras que en el 2022 fueron Huánuco, Moquegua, manteniéndose Ayacucho y Apurímac con cifras que varían entre el 80% - 87.8%; y en cuanto a los departamentos que presentaron menores porcentajes, en el 2017 fueron Tumbes, Ica y Madre de Dios, mientras que en el 2022 fueron Piura y Madre de Dios con cifras que varían entre 35.2% - 49.8%. En la capital, Lima, las cifras se fueron en descenso, ya que la práctica de la LME en el 2017 se encontraba entre 60% - 68%, y en el 2022 fue entre 50% - 58.7% ⁽⁹⁾.

Cuando se carece de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva se corre el riesgo de que la madre no cuente con las herramientas necesarias para contribuir con la salud de su hijo, o también la posibilidad de que se presenten dificultades para que lo pueda amamantar de manera satisfactoria. Muchas

veces las madres no poseen una información completa sobre el tema, es por eso que algunas de ellas introducen líquidos adicionales como agua o manzanilla antes de que el lactante cumpla los seis meses de edad, que es justo la etapa en donde se inicia su alimentación complementaria. Por eso, según López A. et al. en 2021, destacan que existen numerosos estudios biológicos que demuestran la decisión de la madre para no dar de lactar a su hijo, ocasionando perjuicios a nivel físico; por lo que afirman que la alimentación en base a leche materna de forma exclusiva es una estrategia sanitaria que aporta de forma significativa al bebé y a la madre, sin incrementar los costes económicos ⁽¹⁰⁾. Sin embargo, debido a la información distorsionada e incompleta que reciben las madres por diversas fuentes de información o por apegarse a costumbres familiares ocurre el abandono del amamantamiento, que se evidencia el descenso en las cifras estadísticas ^(6,7,9); por otro lado Gonzales A., et al. en 2022, consideran que existen ciertos elementos que llevan a la madre a no realizar la LME, señalando el hecho de ser primípara, de no tener leche, no contar con economía suficiente o ayuda familiar, y situación laboral. Además, atribuye que la pandemia por COVID-19, generó muchas dudas en las madres sobre la acción de amamantar a sus bebés porque pensaban que podría ser una vía de contagio, y se añadió falta de educación que había en ese entonces sobre la importancia de la LME, debido a que los establecimientos de salud estaban priorizando a la población enferma por este nuevo virus ⁽¹¹⁾.

En Guatemala, un estudio por Marroquín F., Pichiyá S., y Pérez AG ⁽¹²⁾, en el 2021, señalan que más del 60% de madres presentan un nivel de conocimiento medio, y que casi el 42% desconoce sobre los beneficios que brinda.

Otra investigación realizado en Ecuador, por Albán I. y Yépez B ⁽¹³⁾, mencionan que casi el 40% de las madres que asisten a los centros de salud N°1 y N°4 ha brindado lactancia materna en la primera hora de vida de su bebé, y que el 12% de ellas aseveran que la LME se da solo hasta los 3 meses de edad.

Estudios realizados en el Perú, demuestran el desconocimiento que las madres tienen sobre la LME. Así, un estudio de Obregón J. ⁽¹⁴⁾ en el 2018, en un centro

materno infantil llamado Tahuantinsuyo Bajo, en Lima, señala que el 49 % de madres no conocen sobre la importancia y los beneficios de la LME.

En otra investigación por Velázquez M. ⁽¹⁵⁾ en el 2018, realizado en el centro de salud Carlos Protzel, en Comas, evidencia que casi el 54% no conocen sobre la importancia de brindar lactancia materna en la primera hora de vida.

También, Bautista Y. y Diaz I. ⁽¹⁶⁾ en 2017, señalan en su estudio que más del 50% presentan un nivel bajo de conocimiento y que el 72% de ellas no pone en práctica la LME con sus bebés.

En este sentido, el profesional de enfermería que se encuentra en el primer nivel de atención, contribuye en la prevención de enfermedades e interviene anticipadamente en algún problema de salud de la población ⁽¹⁷⁾. Es por eso, que enfermería promociona, fomenta y educa sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva, para que el bebé crezca y se desarrolle adecuadamente. Educar a las madres refuerza e incrementa sus conocimientos sobre el cuidado idóneo que un bebé necesita, ya que ellas son responsables del bienestar de sus hijos. Las enfermeras y enfermeros se cruzarán con madres de diferentes realidades, culturas y costumbres, por ello es primordial informar de forma clara, sencilla y precisa, para que esta comprenda y entienda lo indispensable que es la leche materna.

Durante las prácticas del internado en el Centro de Salud de Zárate, se pudo presenciar la gran cantidad de madres primerizas, al igual que de madres con varios hijos. La mayoría de ellas se encontraban angustiadas a la hora de hablar sobre la lactancia materna exclusiva; dado que, por miedo, timidez o vergüenza no preguntan, además de que, las que ya tienen hijos anteriores hacen comentarios referente a la LME, mencionando lo doloroso y agotador que es realizarlo; a pesar de todo ello, se destaca que la mayoría tiene la iniciativa y la disposición de alimentar a sus bebés a través de la LME.

Las madres que se encontraban en la sala de espera, estaban ahí porque sus bebés tenían que ser vacunados o porque les tocaba control de Crecimiento y Desarrollo en el niño sano (CRED) y manifestaban entre ellas: “Yo le doy mi

pecho y no se llena, por eso le tengo que complementar con fórmula” “la fórmula no le ha dado gases a mi bebé como me habían dicho por ahí” “Me duele mucho la espalda, creo que le daré fórmula nomas” “prefiero darle fórmula para que no me cause dolor” “Mi bebé aún no sabe agarrar bien mi seno y por eso me lastima” “yo he dado de mamar a mi hijo mayor por unos meses, luego le di fórmula y él está sanito” “mi bebé no succiona mucho mi seno y casi no me sale leche” “como no puedo producir mucha leche, le he tenido que dar fórmula, porque mi bebé llora de hambre”.

Después de todo lo mencionado amerita preguntarse: ¿Saben las madres la importancia de la lactancia materna exclusiva? ¿Conocerán las madres la técnica adecuada de amamantamiento? ¿La madre sabrá sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva? ¿Saben las madres hasta qué edad se debe realizar la lactancia materna exclusiva? ¿Conocerán el motivo del porqué no producen la suficiente leche materna?

- **Formulación del problema:**

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden al Centro de Salud Zárate, Lima - 2024?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

- Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden al Centro de Salud Zárate, Lima – 2024

1.3.2. Objetivos Específicos:

- Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión aspectos generales en madres que acuden al Centro de Salud Zárate.
- Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión técnica de amamantamiento en madres que acuden al Centro de Salud Zárate.

1.4. Importancia y alcance de la investigación (Justificación)

La lactancia materna exclusiva es el alimento esencial que un niño debe recibir durante los primeros 6 meses de vida, ya que incrementa su sistema inmunológico que lo protege de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y nutricionales para que crezca y se desarrolle favorablemente. Por tal motivo, es importante que la madre conozca sobre todo lo que concierne a la lactancia materna exclusiva, ya que con la información adquirida tendrá razones suficientes para saber cómo actuar a favor de la salud y bienestar de su hijo, evitando dificultades físicas y psicoemocionales a corto y a largo plazo.

El profesional de enfermería que se encuentra en el primer nivel de atención se encarga de promocionar la LME y de educar a la comunidad, haciendo mayor énfasis en las madres y futuras madres, ya que son las responsables de realizar la acción de amamantar. Por ello, proporcionar charlas educativas y demostrativas a las madres permitirá un impacto positivo y reflexivo que fortalecerá la decisión de brindar LME; y junto al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) ⁽¹⁸⁾, quien aporta una guía técnica sobre lactancia materna como recurso educativo para la población en general, se podrá dar a conocer sobre las ventajas que producen en el niño, la madre, la familia y la sociedad, así como los riesgos que se pueden presentar cuando el bebé no es amamantado.

Los resultados obtenidos en este estudio aportarán diferentes planes y estrategias educativas que generen conciencia sobre la LME, para difundirla y promoverla. Inclusive, ayudará a realizar un reconocimiento de la realidad en nuestra actualidad, identificando que aspectos sobre lactancia materna exclusiva deben reforzarse en la población materna. Por último, será de utilidad para los próximos investigadores que realicen un estudio referente al tema.

Asimismo, los resultados fidedignos permitirán a la enfermera educar a la madre sobre los puntos más relevantes de la lactancia materna exclusiva, como: la preparación del seno antes de amamantar; la posición y técnica correcta del bebé y de la mamá; la técnica de extracción, conservación y administración de la leche materna; y esencialmente sobre los beneficios a corto y a largo plazo en la salud infantil y materna ⁽¹⁹⁾, con la finalidad de corregir, pero sobre todo ampliar sus conocimientos sobre el tema.

1.5. Limitaciones de la investigación

Dentro de las limitaciones que se presentaron fue la restricción de estudios relacionados al tema debido a la pandemia por Covid-19, y la escasa cantidad de bibliografía internacional actualizada.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1. A nivel Internacional

Arcentales J., en 2023, en Ecuador, realizó un estudio con el objetivo evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes hospitalizados en el Hospital Pediátrico Baca. Investigación descriptiva, observacional y de corte transversal. La muestra poblacional 102 madres. El instrumento un cuestionario. Resultados: 56,8% de las madres tienen nivel de conocimiento medio y el 10,7% conocimiento bajo sobre lactancia materna exclusiva. Conclusión:

“Las madres que son estudiantes, amas de casa, [...], obtuvieron un nivel de conocimiento medio; y las madres que culminaron primaria y secundaria también poseen un nivel medio”. ⁽²⁰⁾

Marroquín F., et al. en 2021, en Guatemala, hicieron una investigación con el objetivo de identificar el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y las

características demográficas de las madres. Estudio descriptivo, transversal y cuantitativo. La muestra poblacional 301 madres. Técnica encuesta e instrumento un cuestionario. Resultados: 38,7% de las madres desconocen sobre la lactancia materna exclusiva y sus beneficios. Como conclusión indican:

“La mayoría de las madres tiene un nivel medio de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva...”. ⁽¹²⁾

Mamani Y., et al. 2017, desarrollaron un estudio titulado “Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en Cochabamba – Bolivia: un estudio departamental, 2017”. Investigación poblacional, observacional y descriptivo de corte transversal. La muestra poblacional 3515. La técnica encuesta y el instrumento un cuestionario estandarizado. Resultados: 14,1% no tiene conocimiento sobre el inicio temprano del amamantamiento y 19,2% no conoce la duración de una lactancia materna exclusiva. Entre sus conclusiones menciona:

“Se cuenta con índices elevados de Lactancia Materna Exclusiva, porque la mayoría presenta conocimiento, cuyos indicadores se ven asociados a factores sociodemográficos como la edad, [...]. La región Andina fue la que presentó los mejores indicadores y por el contrario la región Metropolitana los más bajos [...]”. ⁽²¹⁾

Albán I. & Yépez B, en 2016, en Ecuador, elaboraron una investigación que tiene como objetivo describir los conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia de las madres que acuden a diferentes Centros de Salud en Quito. Estudio cuantitativo y de corte transversal. La muestra poblacional es 212 madres. La técnica una encuesta y el instrumento un cuestionario con preguntas de opción múltiple. Resultados: el 36% desconoce que la lactancia materna inmediata se brinda durante la primera hora de vida del bebé y 37% de ellas desconoce la duración de la lactancia materna exclusiva. Entre las conclusiones destacan:

“Un alto porcentaje de las madres asocia la lactancia materna con el beneficio de crear lazos afectivos madre-hijo, lo cual influye de manera positiva [...]” ⁽²²⁾.

2.1.2. A nivel Nacional

Berrocal M., Flores B. & Solano A., en 2021, en Huancayo, hicieron un estudio denominado “Conocimientos y prácticas sobre la lactancia materna en madres adolescentes en el Centro de Salud Chilca”. Pesquisa cuantitativa, descriptiva y de corte transversal - correlacional no experimental. La muestra poblacional 60 madres. Técnicas empleadas encuesta y guía de observación, el instrumento un cuestionario. Resultados: 46,67 % de madres presenta un nivel de conocimientos regular y 18,33% un nivel deficiente en lactancia materna exclusiva. Además, 63.3% nivel deficiente y 30% regular sobre las ventajas; y 75% tiene conocimiento regular en cuanto a la técnica de amamantamiento. Se concluye que:

“A mayor es el conocimiento de cómo ser madre se va a poder saber el cómo atender a los hijos en cuanto al acto de lactancia materna exclusiva” ⁽²³⁾

Palomino N., en 2019, en Cañete, elaboró una investigación con objetivo de evaluar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en puérperas de 20 a 35 años del Hospital Rezola. Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y de corte transversal. Población 180 madres y su muestra 123. Técnicas empleadas encuesta y guía de observación, el instrumento un cuestionario. Resultados: 65 % de las madres presentaron nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna exclusiva y 28,5% bajo. Entre sus conclusiones:

“La mayor proporción de madres presenta conocimientos entre nivel medio y bajo sobre lactancia materna exclusiva, al igual que en todas sus dimensiones”. ⁽²⁴⁾

Bocanegra J. & Calderón G., en 2019, Amazonas, realizaron una investigación titulada “Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas del Hospital María Auxiliadora Rodríguez de Mendoza”. Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. La muestra poblacional fue 41 madres. La técnica encuesta y el instrumento un cuestionario. Resultados: 65,9% de las madres presentó nivel de conocimientos medio en dimensión generalidades; en la dimensión ventajas para el niño: 46,3% conocimiento medio y 43,9% conocimiento bajo; y en dimensión ventajas para la madre: 73.2% conocimiento bajo. Dentro de sus conclusiones se encontraron:

“La mayoría de las mismas presentan niveles de conocimiento bajo, siendo las dimensiones más desconocidas por las madres las ventajas de la lactancia materna para la madre, las contraindicaciones [...]. Sin embargo, hay factores externos, como los socioeconómicos y culturales que influyen [...]”. ⁽²⁵⁾

Vásquez P., 2019, en Cajamarca, efectuó un estudio denominado “Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de seis meses. Centro de Salud Pachacútec”. Investigación no experimental, descriptivo, de corte transversal y correlacional. La población fue 720 madres y la muestra 85. La técnica fue entrevista directa y el instrumento un cuestionario. Resultados: el 47,1% de las madres obtuvo nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna exclusiva, y 3.5% nivel bajo. Concluyendo que:

“El grado de instrucción de la madre si influye en el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva [...]; a pesar de eso, la mayoría de las madres tienen conocimiento alto sobre lactancia materna exclusiva.”. ⁽²⁶⁾

Marquina P., en Lima, realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento de las madres de menores de seis meses sobre lactancia materna exclusiva en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Sergio E. Bernal en el periodo noviembre-diciembre, 2018”. Estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La población 84 madres y la muestra 39. La técnica fue encuesta y

el instrumento un cuestionario. Resultados: el 46% de las madres presentan nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna exclusiva y 26% nivel bajo". Entre sus conclusiones:

"La mayoría de las madres de menores de seis meses poseen un nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva medio, conceptos básicos nivel medio, técnicas de amamantamiento un nivel bajo y las contraindicaciones nivel medio". (27)

Velásquez C. en 2017, en Chimbote, desarrolló una pesquisa con el objetivo de determinar los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores de 6 meses que acuden a un centro de salud. Investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y transversal. La población fue 195 madres y la muestra 130. Técnica encuesta e instrumento un cuestionario. Resultados: 42,31% obtuvo nivel de conocimientos medio y 32,31% nivel bajo. Dimensión aspectos básicos: 40% nivel medio y 30,77% nivel bajo; importancia: 46,92% nivel medio y 31,54% nivel bajo; beneficios y ventajas: 42,31% nivel medio y 34,62% nivel bajo. Se concluye que:

"El conocimiento sobre el amamantamiento es importante para su ejecución, ya que permite a las madres poder realizarlo con mayor motivación y satisfacción". (28)

Baila B. y Quevedo M., en 2016, en Lambayeque, ejecutaron un estudio denominado "Relación entre conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en madres del Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Hospital Referencial de Ferreñafe". La investigación de tipo cuantitativa descriptiva. La población 384 madres y la muestra de 214. Técnica encuesta y el instrumento un inventario. Resultados: el 89,7% de madres tienen un nivel de conocimiento medio sobre lactancia materna. Dentro de las conclusiones:

"La mayoría de las madres presenta un nivel medio de conocimientos, lo que demuestra que las actividades de educación realizadas por la enfermera [...], además se debe trabajar en la promoción [...]". (29)

García LA., en 2015, en Lima, realizó una investigación titulada “Nivel de conocimientos de las madres menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva en el Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo”. Estudio descriptivo y corte transversal. La población 70 madres y la muestra 60. Técnica una entrevista y el instrumento un cuestionario. Resultados: el 51,6% de las madres tiene conocimiento medio y 41,7% conocimiento bajo sobre lactancia materna exclusiva. En conclusión:

“Se evidencia la importancia de la educación que brinda el profesional de salud [...] para incrementar el nivel de conocimientos que repercuten de manera favorable en el crecimiento y desarrollo sano del niño”.⁽³⁰⁾

En este estudio cada aporte bibliográfico va a contribuir sobre los conocimientos de las madres de familia, que notificará a la institución pública que permita organizar charlas educativas teniendo en cuenta las necesidades que la madre presente, para favorecer sus conocimientos y así incrementar la práctica de lactancia materna exclusiva a través de la concientización.

2.2. Bases teóricas:

Lactancia Materna Exclusiva en niños menores de 6 meses

Bases conceptuales de la Lactancia Materna

Según la OMS, la lactancia materna es la forma eficaz para garantizar la salud y supervivencia de los niños⁽³¹⁾, ya que es la fuente principal de alimentación porque brinda los nutrientes necesarios al infante durante los 2 primeros años de vida⁽¹⁸⁾.

Fisiología de la lactancia materna

En el embarazo, los senos de la futura madre se encuentran en preparación y desarrollo para poder realizar su función principal, la cual es alimentar al bebé. El seno materno se encuentra listo para brindar leche materna a partir de la semana 16 de gestación sin necesidad de intervenir activamente.⁽³²⁾

El inicio de la secreción láctea o lactogénesis, se ha descrito mediante tres estadios:⁽³¹⁾

Estadio I: Se inicia unas doce semanas antes del parto.

Estadio II: Se inicia clínicamente dos o tres días después del parto, cuando la secreción de leche es copiosa.

Estadio III o galactopoyesis: Se considera el mantenimiento de la lactancia ya establecida.

Fisiología de la glándula mamaria

La leche materna se produce por las células que se encuentran en la glándula mamaria de la mujer, esta es almacenada en los alvéolos para terminar secretando a través de los conductos lactíferos. Para que se genere la leche se necesita de dos hormonas muy importantes; la prolactina va a permitir su producción, mientras que su secreción va a estar encargada de la oxitocina. Ambas van a depender de la succión adecuada que es realizada por el lactante ⁽³²⁾.

Anatomía del seno materno

Ambas mamas que posee una mujer están compuestas principalmente por tejido glandular, de soporte y adiposo. Se van a situar entre el segundo y el sexto espacio intercostal de la pared torácica, lo cual va a beneficiar la colocación del bebé al momento de la lactancia. Las mamas no son iguales para todas las mujeres, por lo cual van a poseer características individuales, lo cual no interviene con la producción de la leche ⁽³³⁾.

Pezón

Está localizado en el centro de la areola. Contiene fibras musculares lisas que actúan como esfínter para los conductos y senos galactóforos; y está formado por abundantes terminaciones nerviosas, sensitivas y anastomosis arteriovenosas ⁽³⁴⁾.

Además de ser punto de referencia para que el bebé pueda hallar el seno materno. Asimismo, es por donde la leche se excreta desde el interior de la mama hacia el exterior ⁽³⁵⁾.

Areola

Es un área pigmentada circular que va a rodear al pezón y posee diversas glándulas sudoríparas y sebáceas independientes, las cuales se abren en los tubérculos de Montgomery (sirve como estímulo olfativo para los recién nacidos) ⁽³⁴⁾.

Tejido mamario

Está constituido por glándulas mamarias, conductos galactóforos y tejido de sostén (tejido mamario denso), y tejido graso (tejido mamario no denso). Está vascularizado por vasos perforantes de la arteria y venas mamarias internas, así como de los vasos torácicos laterales ⁽³⁶⁾.

Composición de la leche materna

Macronutrientes: Se compone por los carbohidratos, que es el azúcar principal es la lactosa, que mantiene la densidad de la leche a través del agua. También, se encuentran oligosacáridos como: glucosa, galactosa, entre otros; los cuales abarcan el 1.2% de la leche materna. Luego, se encuentran las grasas, que presenta muchas variaciones, ya que varía en el tiempo y brinda hasta 55% de kilocalorías, posee como mayor componente a los triglicéridos; y se ha demostrado que los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran presentes en este componente y que brindan beneficios a nivel del sistema nervioso central (SNC). También se ubican las proteínas, la cual constituye el 0.9% de la leche materna, en donde la caseína ocupa un 40% y el restante a la lisozima, la lactoalbúmina, la lactoferrina que ayudan en la absorción del hierro en el intestino; y posee inmunoglobulinas, en donde la IgA secretora cumple una función fundamental como protectora ⁽³⁷⁾.

Micronutrientes: Se compone de vitaminas que se encuentran presentes en la leche materna; sin embargo, cuando un niño nace las concentraciones de potasio se encuentran bajas, por ello se debe aplicar una dosis de vitamina K. Después, se tienen los minerales y elementos traza, los cuales están en cantidades necesarias para un lactante ⁽³⁷⁾.

Otros componentes: aquí encontramos al agua, que es el componente de la leche que en más proporción se encuentra (hasta 90%) y si se relaciona con la hidratación de la madre; y también a los nucleótidos que permite incrementar la respuesta inmunológica, mejorando el perfil lipídico y la maduración del epitelio intestinal ⁽³⁷⁾.

A. ASPECTOS GENERALES DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

A.1. Definición de Lactancia materna exclusiva (LME)

Se refiere a la acción de brindar leche materna al bebé, sin la necesidad de agregar otros líquido o sólidos ⁽³⁸⁾. También, se le considera un proceso biológico que atraviesa la mujer que se convierte en madre, quien tiene el objetivo de alimentar al recién nacido hasta los 6 meses de edad, beneficiando en su crecimiento saludable ⁽³⁹⁾. La leche materna de forma directa del seno de la madre al niño es el único alimento esencial que va a brindar los nutrientes necesarios, y adicionalmente va a generar anticuerpos que lo va a proteger de diversas enfermedades ⁽⁴⁰⁾.

A.2. Inicio temprano de la lactancia materna

En la primera hora de vida, es fundamental que reciba lactancia materna porque es donde recibe el calostro, líquido amarillo denso y viscoso que brinda muchos nutrientes y actúa como protector, además de ser de fácil digestión para el estómago del lactante ⁽⁴¹⁾.

Es importante, porque permite reducir el riesgo de morir en casi el 20% durante su primer mes de vida ⁽⁴²⁾.

A.3. Importancia de la Lactancia Materna Exclusiva

La lactancia materna exclusiva a través de la leche permite nutrir al niño para su crecimiento y desarrollo, y actúa como protector de enfermedades, infecciones y alergias. Debido a todo ello, se reduce la probabilidad de que pueda desarrollar obesidad ya sea en edad infantil como adulta ⁽⁴³⁾.

A.4. Tipos de leche materna

- **Calostro:** es la primera leche de color amarillo o color paja producido por el seno materno y tiene una duración de hasta 3 días. La producción se dará entre 40 y 50 ml durante un día, lo cual es lo necesario para el estómago de un recién nacido ⁽³⁷⁾. Se compone de 87% de agua; 2.9g/100 ml. de grasa; 5.5g/100ml de lactosa y 2.3g/ 100 ml. de proteínas proporcionando 58 Kcal/100 ml ⁽³⁶⁾.
- **Leche de transición:** Se produce entre cuarto y décimo día luego del parto ⁽³³⁾, hacia el quinto día hay un aumento brusco de su producción y va incrementando su volumen hasta llegar a 600 ml/día aproximadamente entre los 15-30 días posparto ⁽⁴⁴⁾.
- **Leche madura:** El volumen aproximado es de 700- 900 ml/día durante los 6 primeros meses posparto ⁽⁴⁴⁾.

A.5. Beneficios de la Lactancia Materna Exclusiva

Para el bebé: brinda un buen desarrollo físico y emocional, disminuye el riesgo de contraer enfermedades tanto a corto como a largo plazo, ayuda con una buena digestión, fortalece el vínculo emocional con la madre y genera una mayor inteligencia intelectual ⁽⁴⁵⁾.

Para la madre: ayuda en una recuperación postparto más efectiva y en menor tiempo, brinda menor riesgo de sufrir de sobrepeso y obesidad, disminuye la probabilidad de padecer cáncer mamario y de ovario, así como de la osteoporosis, genera mayor satisfacción personal y una mejor autoestima, y fortalece los lazos afectivos con el hijo ⁽⁴⁵⁾.

Para la familia: genera menos gastos económicos porque se evita la compra de fórmulas lácteas, menor ausencia laboral porque los padres podrán trabajar con tranquilidad debido a que el niño se encontrará saludable, fortalece el contacto afectivo bebé – familia, brinda una disponibilidad inmediata y reduce el tiempo a la hora de brindar la comida, pues no hay necesidad de preparar biberones ⁽⁴⁵⁾.

B. TÉCNICA DE AMAMANTAMIENTO

La madre es libre de elegir la forma o posición que más se acomode y le brinde una mayor facilidad de poder brindar la leche materna al bebé; no obstante, debe cerciorarse de que su técnica sea adecuada en cualquiera de las posiciones en las que elija dar de lactar, en el lugar en que se pueda encontrar ⁽⁴⁶⁾.

B.1. Medidas de higiene

Existen ciertas medidas de higiene que la madre debe realizar para brindar una adecuada lactancia materna, como el lavado de manos con agua y jabón antes de amamantar y el aseo personal, es decir, bañarse a diario ⁽⁴⁷⁾.

B.2 Posición de la madre

Como ya se mencionó, la madre es libre de elegir la posición en la más se sienta cómoda, y no olvidarse de que la espalda siempre debe estar apoyada. Por ello, es importante que conozca la forma adecuada para que el lactante tenga un buen agarre, lo cual le va a permitir succionar de forma correcta y así no generar heridas en el seno materno. Las posturas para amamantar son: ⁽⁴⁸⁾

- **Posición de cuna o sentada:** el bebé es colocado con el tronco enfrentado y pegado a la madre entre sus brazos. La cabeza del lactante debe estar apoyada en el antebrazo; y con ayuda de la otra mano se coge el seno para acercarlo al bebé y pueda empezar a mamar.
- **Posición acostada:** la madre se acuesta de lado junto al bebé, ambos con su cuerpos enfrentados y pegados uno del otro. Es la posición más frecuente para las tomas nocturnas y los primeros días que se amamanta.

- **Posición crianza biológica:** la madre se recuesta entre 15° y 65° mirando hacia arriba, mientras el bebé hacia abajo. Es una posición que ayuda cuando no hay un buen agarre por dolor, grietas, etc.
- **Posición en balón de rugby o invertida:** se coloca al bebé por debajo de la axila de la madre con las piernas hacia atrás y su cabecita a nivel del seno materno. Se debe sujetarle el cuello y los hombros, pero no a la cabeza, ya que necesita estar con el cuello un poco estirado para ayudar a un buen agarre.
- **Posición del caballito:** se posiciona al bebé sobre una de las piernas de la madre, pegado a su abdomen. La madre lo toma con el dedo índice y el pulgar detrás de las orejas, mientras la muñeca junto al brazo va en el dorso del lactante.

Es importante que cuando se realice el acercamiento de la boca del bebé con el seno de la madre, esta última debe tener sostenido con la otra mano el seno en forma de “C” y verificar que el lactante tome el pezón y parte de la areola con la boca bien abierta ⁽⁴⁹⁾.

B.3. Posición del lactante

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: ⁽⁴⁹⁾

1. La cabeza y todo el cuerpo del lactante debe estar inclinado siguiendo el eje del seno materno.
2. La cara del bebé debe estar frente al seno y su barriga pegado al de la madre.
3. Su oreja, hombro y cadera deben trazar una línea recta.

B.4. Signos de un buen agarre

El agarre se va a considerar correcto cuando el lactante: ⁽¹⁸⁾

1. Tiene la boca bien abierta y abarca gran parte de la areola
2. Su labio inferior está hacia afuera (evertido)
3. Su mentón toca el seno
4. Abarca con su boca más areola por debajo, que por la parte superior

B.5. Signos de una buena succión

Cuando el lactante succiona de manera efectiva es porque el agarre ha sido el correcto. Esto es un indicador de que la leche está fluyendo de forma adecuada. Se considera una buena succión cuando: ⁽⁵⁰⁾

- Las succiones son lentas y profundas, con una deglución visible o audible. Puede haber pausas cortas, lo cual permite que los conductos nuevamente se llenen de leche. Al final de cada mamada, la succión se puede volver menos profunda y darse pausas más prolongadas.
- Las mejillas del lactante permanecen redondeadas.

B.6. Signos de una mala succión y agarre

Cuando no hay una succión efectiva, genera consecuencias como: ⁽¹⁸⁾

- El seno de la madre se ingurgite y se pueden llegar a obstruir los conductos lactíferos, lo que podría generar grietas o heridas.
- La cantidad de leche que absorbe es insuficiente, lo que genera que el bebé no gane peso.
- Rechazo del seno por parte del lactante

B.7. Duración y frecuencia de las mamadas

La frecuencia de los lactantes al alimentarse va a variar, ya que toman diferentes cantidades de leche en cada mamada, pero es importante que la madre sepa que debe dar de lactar a demanda, y entre 8 a 12 veces por día aproximadamente ⁽¹⁸⁾.

Cuando el niño tiene mamadas muy largas, es decir, más de 30 minutos; o si tiene la necesidad de hacerlo de manera muy frecuente, cada 1h o 1h y 30min, es necesario supervisar y verificar constantemente el agarre y la succión del lactante, para tener la certeza de que está lactando adecuadamente ⁽⁵⁰⁾

C. Los 10 pasos para una lactancia materna exitosa

Se elaboraron diez pasos por la OMS y UNICEF, con el propósito de que la lactancia materna se realice de forma natural, el cual deben cumplir los establecimientos de salud. Los cuales son: ⁽¹⁸⁾

1. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna y las resoluciones correspondientes a la Asamblea Mundial de Salud.
2. Capacitar al personal de salud y evaluarlos de manera constante.
3. Informar a las madres y sus familias sobre los beneficios de la lactancia materna.
4. Fomentar el contacto piel con piel con el recién nacido, de forma directa e ininterrumpida luego de su nacimiento.
5. Enseñar a las madres la forma correcta de realizar la práctica del amamantamiento y cómo poder mantenerlo frente a ciertas dificultades.
6. Promover la lactancia materna exclusiva, en donde no se incluya ni líquidos ni sólidos, a excepción de alguna recomendación médica.
7. Permitir la convivencia entre la madre y el recién nacido.
8. Enseñar a las madres a identificar los signos que indican que el bebé quiere mamar.
9. Aconsejar sobre los efectos negativos del uso de biberones, chupones o botellas.
10. Invitar a las madres a los grupos de apoyo sobre lactancia materna para que exista una atención continua luego de su alta hospitalaria.

D. Crecimiento y desarrollo del lactante menor de 6 meses

Desarrollo Motor

Es el proceso del bebé en donde adquiere las habilidades motoras de manera continua y secuencial, que empieza con movimientos sencillos y vagos y evolucionan a movimientos más finos y organizados ⁽⁵¹⁾.

Dentro de su desarrollo motor se encuentra:

Motricidad gruesa: se encarga de movimientos grandes, ya que se utilizan grupos grandes de músculos para alcanzar el movimiento, equilibrio y

estabilidad, como son el gatear, caminar, saltar, etc. Es la primera que se desarrolla ⁽⁵¹⁾.

Motricidad fina: se encarga de los movimientos finos con partes pequeñas del cuerpo, como dedos de las manos o pies, boca, lengua, etc. ⁽⁵¹⁾.

Ambos tipos de motricidad se complementan, ya que se necesitan para realizar los movimientos de forma adecuada.

El progreso del desarrollo motor:

Recién nacido a 3 meses ⁽⁵²⁾

- Reflejos de búsqueda: se produce cuando se toca o acaricia la comisura de los labios del bebé, y esta gira la cabeza y abre la boca para seguir y "buscar" en esa dirección. Esto ayuda al bebé a encontrar el seno materno o el biberón para poder alimentarse. Dura alrededor de cuatro meses.
- Reflejo de Succión: se produce cuando el techo de la boca del bebé entra en contacto, y comienza a succionar.
- Reflejo de Prensión: es cuando se acaricia la palma de la mano del bebé y provoca el cierre de los dedos en un apretón. Dura hasta aproximadamente los cinco o seis meses de edad.
- Reflejo de Moro: se denomina reflejo de sobresalto porque generalmente se produce cuando el bebé se sobresalta por un sonido o un movimiento estrepitoso.
- Se puede concentrar en las miradas
- Persigue la luz o los objetos con la mirada
- Levanta su cabeza estando acostado hacia abajo
- Empieza a sonreír
- Abre y utiliza con mayor facilidad sus manos
- Puede sostener su cabeza un tiempo más prolongado (a los 3 meses)

Bebe de 4 a 6 meses ⁽⁵¹⁾

- Control completo de cabeza y cuello.
- Reacciona ante el sonido
- Voltea de forma automática
- Se mira en el espejo y sonríe
- Agarra objetos con mayor tamaño y juega pasándolo de una mano a otra

- Gira sobre su abdomen
- Descubre sus extremidades
- Levanta la cabeza y su tórax con mayor facilidad
- Comienza a sentarse con apoyo

Desarrollo Verbal

0 a 3 meses

Su única forma de comunicación oral es el llanto, que puede significar hambre, sueño o incomodidad; además, pueden responder a las palabras, pero con expresiones faciales. A partir del segundo mes, empiezan a emplear o balbucear vocales y emiten sonidos utilizando letras como la “g”, “k” y “j” ⁽⁵⁰⁾.

4 a 6 meses

Los sonidos que emiten se dirigirán a las personas que les hable, y comenzarán a realizar gritos intencionales que les parecerá gracioso, también empieza a reconocer las voces de sus parientes (sobre todo de la mamá), y podrá imitar ciertos sonidos ⁽⁵⁰⁾.

Desarrollo Cognitivo

0 a 3 meses

El bebé en esta etapa duerme mucho y solo despiertan para comer o porque se sienten incómodos por el pañal sucio; los sonidos le llaman la atención y podrá reconocer levemente a sus padres y personas con las que tenga más contacto ⁽⁵⁰⁾.

4 a 6 meses

Puede expresar risas más duraderas y con sonidos más fuertes; asimismo, los ruidos externos pueden provocar que voltee en dirección a ellos. También ya reconoce con mayor claridad a sus padres y empieza a negarse cuando se le acercan personas extrañas, aquí disfruta mejor el jugar ⁽⁵⁰⁾.

E. Rol de enfermería en la promoción de la lactancia materna

El profesional de enfermería tiene la función de brindar educación a la madre desde la etapa de gestación hasta el momento del nacimiento del bebé; enseñándoles sobre las técnicas adecuadas de amamantamiento, fomentando que la realicen de forma exclusiva durante los primeros 6 meses del bebé, y que a partir de esa edad puede brindar leche materna paralelamente con la alimentación complementaria hasta que el niño cumpla sus 2 años. Además, tienen la tarea de brindar apoyo durante la primera hora de vida del niño. Debido a que la enfermera está encargada del Control de Crecimiento y Desarrollo del menor, donde lo evalúa periódicamente. Por lo que, es importante que cuente con las habilidades pertinentes para facilitar la práctica de la lactancia materna. Asimismo, los enfermeros y enfermeras tienen el trabajo de concientizar a las madres sobre la importancia de realizar la lactancia materna exclusiva, mencionando las ventajas que le ofrece al niño, a ellas, a sus familias e incluso a la misma sociedad ⁽⁵³⁾.

Teoría de Ramona Mercer: Adopción del rol maternal

Lo que propone Ramona Mercer con su teoría es que los profesionales de enfermería tengan en cuenta a todos los elementos importantes en la adopción del rol materno, como lo son la familia, el trabajo, y otras entidades de la comunidad. Sostiene que la madre atraviesa por un proceso evolutivo e interactivo, por lo que siente ese vínculo con su hijo y va adquiriendo conocimientos nuevos sobre el rol nuevo que le está tocando vivir, sintiendo armonía, intimidad y competencia, el cual genera esa identidad materna ⁽⁵⁴⁾.

F. Generalidades sobre conocimiento

F.1. Concepto de conocimiento

Es la acción de adquirir información acumulada y valiosa que permite la comprensión de la realidad por medio de la razón y entendimiento sobre un tema específico ⁽⁵⁵⁾.

F.2. Nivel del conocimiento

Describe la medida de una cantidad en relación a una escala determinada ⁽⁵⁶⁾. Según Columbié M. et al, cuando se divide el percentil 100 en tres categorías, se obtiene el percentil 33 y el percentil 66, obteniendo lo siguiente ⁽⁵⁷⁾:

Nivel alto: Si el valor promedio de respuestas correctas se encuentra por encima del valor que ocupa el percentil 66. ⁽⁵⁷⁾

Nivel medio: Si el valor promedio de respuestas correctas se encuentra entre los valores que ocupan el 33 y 66 percentil. ⁽⁵⁷⁾

Nivel bajo: Si el valor promedio de respuestas correctas se encuentra por debajo del valor que ocupa el percentil 33. ⁽⁵⁷⁾

2.3. Definición operacional de términos

- **Conocimiento:** información que las madres poseen sobre lactancia materna exclusiva teniendo en cuenta su propia experiencia y de otros medios de aprendizaje.
- **Lactancia materna exclusiva:** es el tipo de alimentación basada sólo en leche materna que la madre proporciona a su hijo durante los primeros 6 meses de vida, y a libre demanda.
- **Leche materna:** es el alimento natural originado por las glándulas mamarias de las madres y que contienen nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo adecuado del lactante.
- **Madre de un lactante:** persona de sexo femenino responsable de amamantar a su hijo durante los primeros seis meses de vida.
- **Lactante:** niño o niña que se alimenta de forma directa y exclusiva de leche materna.
- **Centro de Salud:** establecimiento de salud del primer nivel de atención con actividades que promueven la lactancia materna exclusiva para prevenir enfermedades en los lactantes.

3. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. **Hipótesis:** No aplica en la investigación

3.2. **Variables (Identificación de variable):** Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva: variable cualitativa.

3.3. **Operacionalización de las variables:**

Variable	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Valor Final	Definición Operacional
Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva	Es la información personalizada y subjetiva sobre cuándo y cómo alimentar exclusivamente desde el seno de la madre al lactante, sin tener que introducir líquidos o comida sólida durante los primeros seis meses de vida; debido a que, en este periodo, la leche materna contiene todos los macro y micronutrientes necesarios que su organismo necesita para su crecimiento idóneo.	Aspectos generales	Definición de lactancia materna exclusiva	Alto Medio Bajo	Es el conjunto de ideas o de información que adquieren las madres que acuden al Centro de Salud de Zárate sobre la lactancia materna exclusiva con respecto a su importancia, la duración (inicio y término), la frecuencia, y los beneficios que brinda en la salud del niño y niña, y de la madre, lo cual será medido a través de un cuestionario que tiene como valor final alto, medio y bajo
			Inicio temprano de la lactancia materna		
			Importancia de la lactancia materna exclusiva		
			Tipos de leche materna		
			Beneficios de lactancia materna exclusiva		
		Técnica de amamantamiento	Medida de higiene		
			Reflejo de búsqueda (señal) del bebé		
			Posición de la madre		
			Posición del bebé		
			Signos de un buen agarre		
			Signos de una buena succión		
			Signos de una mala succión y/o agarre		
			Duración y frecuencia de las mamadas		

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Tipo y método de investigación

Estudio de tipo cuantitativo, ya que permitirá la medición y cuantificación de la variable. De nivel aplicativo, porque los resultados permitirán brindar información

valiosa para el profesional de enfermería, con el fin de orientar y mejorar las futuras intervenciones educativas sobre lactancia materna exclusiva dirigidas a las gestantes y a las que ya se convirtieron en madres; método descriptivo, porque se describirán los fenómenos hallados; y, prospectivo, porque los datos e información se registrarán según vayan ocurriendo los hechos ⁽⁵⁸⁾.

4.2. Diseño de investigación

El diseño de investigación es no experimental porque no se va a manipular la variable de estudio, lo que permitirá observar los fenómenos en su contexto natural; y de corte transversal, porque la variable se estudiará en un momento determinado ⁽⁵⁸⁾.

4.3. Sede de estudio

El campo de estudio es el Centro de Salud Zárate, ubicado en Calle Los Chasquis 1084, del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima – Perú, perteneciente a DIRIS Lima Centro.

Este establecimiento de salud está dentro del primer nivel de atención, ya que es el lugar que posee el primer contacto con la familia y la comunidad, debido a la cercanía y presta servicios de consulta médica de forma ambulatoria, promocionando la salud y previniendo la enfermedad, y resolviendo las necesidades más frecuentes y básicas de la población. El horario de atención del Centro de Salud es de 8am hasta las 8pm, por lo que existe turno mañana y tarde.

4.4. Población de estudio

La población estará conformada por todas las madres que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que asisten al Centro de Salud Zárate, para los servicios de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED) y la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI).

4.4.1. Criterios de inclusión

- Madres que brinden lactancia materna exclusiva
- Madres de 18 años a 41 años de edad
- Madres con hijos que se encuentren entre los 0 a 6 meses de edad
- Madres que hablen español
- Madres que no sean analfabetas

4.4.2. Criterios de exclusión

- Madres que no brinden lactancia materna exclusiva
- Madres menores de edad y mayores de 41 años
- Madres que hablen otro idioma diferente al español
- Madres que sean analfabetas
- Madres con alguna discapacidad mental

4.4.3. Muestra y muestreo

No habrá muestra ya que se considerará a toda la población en estudio según criterios de inclusión y exclusión. Se obtendrá el total de madres a través del muestreo no probabilístico por conveniencia, y sólo se encuestará sólo a las madres que acuden al turno mañana y turno tarde en los servicios de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED) y la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del Centro de Salud Zárate.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta y el instrumento cuestionario elaborado por la investigadora, que consta de tres partes: presentación, las instrucciones, datos generales (de la madre y el niño) y específicos. El cuestionario va a constar de 20 preguntas con alternativas de opción múltiple; y 2 del total de las preguntas poseerán imágenes como alternativas. **(anexo 2)**

Por cada respuesta correcta se obtendrá 1 punto, mientras que por cada incorrecta se tendrá 0, teniendo como puntaje final un rango de 0 a 20. Con el valor final alto, medio y bajo. **(anexo 6)**

4.5.1. Validez

La validez del instrumento fue sometido a jueces expertos, conformado por 4 especialistas en el tema, para revisar el constructo y contenido del instrumento. Dentro de ellos se encuentran 2 metodólogos, 1 especialista en pediatría y 1 en neonatología.

Dichos resultados fueron validados a través del Coeficiente de Validez de Contenido según Hernández Nieto **(anexo 5)**, donde se obtuvo como resultado 0,8797, lo que se interpreta como **bueno**.

4.6. Procedimiento y procesamiento de recolección de datos

- En primer lugar, se solicitará a la directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos una carta de presentación dirigida a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, con la finalidad de obtener el permiso correspondiente para el acceso al Centro de Salud Zárate.
- Después, cuando la DIRIS Lima Centro brinde el permiso correspondiente para la aplicación en el Centro de Salud Zárate, se presentará a la médico jefe la carta de aprobación para acceder al establecimiento en cuestión, junto con una solicitud de permiso firmado por la Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, haciéndole conocimiento sobre el objetivo de la investigación y el tiempo estimado que se tomará su ejecución.
- Luego, se procederá a realizar coordinaciones con la jefa médico y las enfermeras encargadas de las áreas de Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) y de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), que son los servicios en donde se intervendrá, para poder iniciar con la aplicación del instrumento.

- Se realizará la aplicación del instrumento en los meses de junio y julio del 2024, en donde se le informará a cada una de las madres encuestadas el objetivo de la investigación, previo consentimiento firmado que garantizará la anonimidad y confidencialidad, asegurando que sus respuestas no serán manipuladas ni distorsionadas.

- Por último, luego de la recolección de datos, estos serán procesados a través del programa estadístico Excel, los cuales pasarán a ser codificados de acuerdo a la tabla de códigos elaborada previamente, para que posteriormente sean colocados en una matriz de datos usando Microsoft Excel 2021, mediante tablas y gráficos.

- Para realizar la medición de la variable nivel de conocimientos se determinó a través de máximos y mínimos: $(0 + 20) \div 3 = 6.7 = 7$

Obteniendo lo siguiente:

14 – 20 es alto

07 – 13 es medio

0 al 06 es bajo.

4.7. Análisis estadístico

Se aplicará la estadística descriptiva que permite el análisis y la presentación de los resultados obtenidos de forma significativa y entendible a través de gráficos, tablas, en porcentajes y frecuencias, para facilitar la interpretación de los datos en base al marco teórico propuesto.

4.8. Consideraciones éticas

Se tendrá en cuenta los principios éticos:

- La autonomía, veracidad fidelidad y confidencialidad, utilizando el consentimiento informado previo **(anexo 3)**, indicando que será confidencial y anónimo ⁽⁵⁹⁾.
- La beneficencia, ya que, en colaboración y participación con las madres, ellas tendrán la oportunidad de medir sus conocimientos y saber qué tipo de información es la que más necesitan ⁽⁵⁹⁾, además que permitirá al Centro de

Salud mejorar en la calidad de su atención, la cual implica brindar una mejor educación a esta población.

- Justicia, porque todas las personas tienen el derecho de adquirir la misma información sanitaria ⁽⁵⁹⁾, que contribuya con su propia salud y la de los miembros de su familia.

VI. ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA

A. Cronograma de Grant

Actividades	2023				2024							
	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos
Elaboración del proyecto de investigación	x	x	x	x								
Aprobación del proyecto de investigación por la UNMSM					x							
Validez y confiabilidad del instrumento						x	x	x				
Aprobación del proyecto de investigación por DIRIS LIMA CENTRO									x	x		
Recolección de datos										x	x	
Procesamiento y presentación de datos											x	
Análisis y discusión											x	
Conclusiones y recomendaciones											x	
Informe final											x	
Presentación y sustentación de investigación											x	x

4.9. Presupuesto

PRESUPUESTO			
Bienes	Cantidad	Costo Unit (S/.)	Costo Total (S/.)
Laptop	1	S/1000.00	S/1000.00
Celular	3	S/700.00	S/700.00
Lapiceros	3	S/2.00	S/6.00
Libreta	1	S/8.00	S/8.00
Corrector	1	S/3.00	S/3.00
Servicios	Cantidad	Costo Unit (S/.)	Costo Total (S/.)
Luz	Por mes	S/100.00	S/300.00
Internet		S/150.00	S/450.00
Transporte		S/50.00	S/150.00
Impresión	265	S/1.00	S/265.00
TOTAL			S/2882.00

4.10. Recursos

- Recursos Humanos
- Asesora metodológica
- Asesora estadística
- Recursos Institucionales
- Biblioteca virtual

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gamboa, Eduardo Hernández. "Genealogía histórica de la lactancia materna." *Revista enfermería actual en Costa Rica* 15 (2008): 1
2. Salazar Scarlet, Chávez Mervin, Delgado Xiomara, Eudis Rubio Tamara Pacheco. Amamantamiento. Arco Venez Puer Ped [Internet]. diciembre de 2009 [citado el 1 de junio de 2022]; 72 (4): 163-166. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010&lng=en.
3. Rosabal Suárez Laritza, Piedra Cosme Belkis. Intervención de enfermería para la capacitación sobre lactancia materna. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 2004 Abr [citado 2022 Mayo 25] ; 20(1): 1-1. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192004000100002&lng=es.
4. Organización Mundial de la Salud. *Alimentación del lactante y del niño pequeño*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding> (Último acceso 25 de mayo del 2022).
5. Lactancia materna y alimentación complementaria [Internet]. OPS.org. [citado el 25 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria>
6. Sólo 4 de cada 10 bebés menores de 6 meses son exclusivamente amamantados en América Latina y el Caribe [Internet]. Unicef.org. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/solo-4-cada-10-bebes-menores-6-meses-exclusivamente-amamantados-america-latina-caribe>
7. UNICEF. *Lactancia Materna*. <https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna> (Último acceso 25 de mayo del 2023).
8. Más del 50% de niños y niñas recién nacidos de todo el mundo no reciben lactancia, lo que incrementa su posibilidad de padecer malnutrición [Internet]. Unicef.org. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/situacion-lactancia-materna-ninos-recien-nacidos-problemas-malnutricion-anemia-obesidad-sobrepeso>
9. INEI. Encuesta demográfica y de Salud Familiar. Perú: Lima; 2022. Gob.pe. [citado el 4 de diciembre de 2023]. Disponible en:

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1898/libro.pdf

10. López de Aberasturi Ibáñez de Garayo Ayala, Santos Ibáñez Nerea, Ramos Castro Yolanda, García Franco María, Artola Gutiérrez Carmen, Arara Vidal Isabel. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio de Zorrotzaurre. *Nutrir hospital* [Internet]. febrero de 2021 [consultado el 8 de febrero de 2024]; 38(1): 50-59. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112021000100050&lng=es
11. Gonzales Aníbal Oblitas, Ortiz José Uberli, Herrera, Cruz Yohana Liseth Flores. Lactancia materna exclusiva en América Latina: una revisión sistemática. ¡Viva el Rev. Salud [Internet]! diciembre de 2022 [consultado el 8 de febrero de 2024]; 5(15): 874-888. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-32432022000300874&lng=es
12. Marroquín Ajpop, F., Pichiyá Barrios, S. P., & Pérez Meléndez, A. G. (2023). Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres con atención del parto en el Hospital General Tipo I del municipio de Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango, Guatemala. Septiembre–Octubre 2021. Disponible en: https://biblioteca.galileo.edu/tesario/bitstream/123456789/1451/1/2021-T-len-007-marroquin_pichiya_perez.pdf
13. Albán Pino PI, Yépez Fasce MB. Conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna de las madres que asisten a los centros de salud n°1, centro de salud n°4, Obrero Independiente y El Placer en la ciudad de Quito en el año 2015. PUCE; 2016.
14. Obregón, J. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva de las madres primíparas en un centro materno infantil de Lima, 2018 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Enfermería; 2019.
15. Velásquez, M. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores de 6 meses que acuden a un centro de salud de Lima, 2018 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Enfermería; 2019

16. Rita, Bautista-Hualpa Y. y Díaz-Rivadeneira I. Conocimientos y prácticas de lactancia materna en madres adolescentes que asisten al Centro de Salud de Bagua. *Rev Enferm. Herediana* 10.1 (2017): 14-21. Disponible en: https://faenf.cayetano.edu.pe/images/2017/revistavol_10/enero_junio/conocimiento_insulina.pdf
17. Vignolo Julio, Vacarezza Mariela, Álvarez Cecilia, Sosa Alicia. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. *Arch. Med Int* [Internet]. 2011 Abr [citado 2023 Oct 21] ; 33(1): 7-11. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es.
18. MINSA. Guía técnica para la consejería en lactancia materna. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Promoción de la Salud. Lima: Ministerio de Salud; 2017. 54 p.
19. Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal. Alvarez M, Angeles AP, Pantoja LR. *Conocimientos sobre lactancia materna en madres primerizas*. *Rev Peru Invest Matern Perinat* 2020; 9(4):10-15.
20. Arcentales J. Nivel de Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres de Lactantes Hospitalizados, en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, noviembre 2023. Tesis para optar el título profesional de Médico. Ecuador: Universidad Católica de Cuenca; 2023.
21. Mamani Y., Olivera V., Luizaga M., Illanes D. Conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en Cochabamba-Bolivia: un estudio departamental. *Gac Med Bolivia* [Internet]. 2017 diciembre [citado 2022 agosto 02]; 40(2): 12-21. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662017000200004&lng=es.
22. Albán Pino PI, Yépez Fasce MB. Conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna de las madres que asisten a los centros de salud n°1, centro de salud n°4, Obrero Independiente y El Placer en la ciudad de Quito en el año 2015. PUCE; 2016.
23. Berrocal, M., Flores, B. y Solano, O. Conocimiento y prácticas sobre la lactancia materna en madres adolescentes en el Centro de Salud “Chilca 2021”. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería, Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad Continental, Huancayo, Perú.

24. Palomino N. Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en púerperas de 20 a 35 años en el Hospital Rezola Cañete, 2019. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Obstetricia, Escuela Académica Profesional de Obstetricia. Perú: Universidad Privada Sergio Bernales; 2019.
25. Bocanegra J., Calderón G. Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres primerizas del Hospital María Auxiliadora Rodríguez de Mendoza - Amazonas 2019 [Trabajo de investigación de segunda especialidad]. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Enfermería, Unidad de Posgrado; 2021.
26. Vásquez P. Conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva en Madres de niños menores de seis meses. Centro de Salud Pachacútec, Cajamarca 2019. [Tesis para optar el título de licenciado]. Perú: Universidad Nacional de Cajamarca; 2019.
27. Marquina P. Nivel de conocimiento de las madres de menores de seis meses sobre lactancia materna exclusiva en servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Sergio E. Bernales en el periodo Noviembre – Diciembre, 2018. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2019.
28. Velasquez C. Conocimiento y Práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses, Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote, 2017. Tesis para optar el título de segunda especialidad en Enfermería en Salud Pública con mención en Salud Familiar y Comunitaria. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega; 2017.
29. Baila Risco BMY, Quevedo Siesquén MM. Relación entre conocimientos y prácticas sobre lactancia materna en madres del programa de crecimiento y desarrollo Hospital Referencial Ferreñafe, 2016. Universidad Señor de Sipán; 2016.
30. García, LA. Nivel de conocimientos de las madres de niños menores de seis meses acerca de la lactancia materna exclusiva. Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, Lima enero 2015. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015.
31. Organización Mundial de la Salud. Lactancia Materna. https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1 (Último acceso 02 de agosto del 2023)

32. Anatomía y fisiología de la lactancia materna. Ocronos - Editorial Científico-Técnica [Internet]. 2019 [citado el 2 de agosto de 2022]; Disponible en: <https://revistamedica.com/anatomia-fisiologia-lactancia-materna/>
33. Society of Spanish Researches in the United Kingdom. Iglesias M. Lactancia materna: por qué y cómo. El punto de vista fisiológico. Diciembre 2019 (citado el 2 de agosto de 2022). Disponible en: <https://sruk.org.uk/es/lactancia-materna-por-que-y-como-el-punto-de-vista-fisiologico/#:~:text=La%20fisiolog%C3%ADa%20de%20la%20gl%C3%A1ndula%20mamaria&text=El%20rol%20del%20beb%C3%A9%20es,trav%C3%A9s%20de%20los%20conductos%20lact%C3%ADferos.>
34. Anatomía de la mama - Lactancia sin dolor [Internet]. Lactancia sin dolor. 2019 [citado el 9 de agosto del 2022]. Disponible en: <https://www.lactanciasindolor.com/lactancia/lactancia-materna/anatomia-de-la-mama/>
35. Ayerra Adela, Zabau Jara, Adán Saray, Barricate. Anatomía y fisiología de la lactancia materna [Internet]. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. Ocronos - Revista Médica y de Enfermería; 2019 [citado el 9 de agosto del 2022]. Disponible en: <https://revistamedica.com/anatomia-fisiologia-lactancia-materna/>
36. Anatomía de la mama [Internet]. Cirugiasdelamama. [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.cirugiasdelamama.com/anatomia-de-la-mama>
37. Sabillón F., Abdu B. Composición de la leche materna. Centro De Capacitación J, Materna L. Bvs.hn. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <http://www.bvs.hn/RHP/pdf/1997/pdf/Vol18-4-1997-7.pdf>
38. Ministerio de Salud y Protección Social. Páginas - Importancia de la lactancia materna [Internet]. Gov.co. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PI/Paginas/ImportanciaLactanciaMaterna.aspx>
39. Verde Carmen Villarreal, Medina Maritza Dorila Placencia, Sifuentes Violeta Alicia Nolberto. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que acuden a establecimientos de salud de Lima Centro. Rdo. fac. Medicina. Tararear. [Internet]. Abril de 2020 [consultado el 30 de noviembre de 2023]; 20(2): 287-294. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000200287&lng=es

40. Lactancia materna [Internet]. Who.int. [citado el 30 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding>
41. Componentes de la leche materna: ¿Qué contiene la leche materna? [Internet]. Medela. 2018 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.medela.es/lactancia/viaje-de-las-madres/componentes-de-la-leche-materna#reference>
42. Mitchell C. OPS/OMS [Internet]. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 2014 [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:breastfeeding-benefits&Itemid=42403&lang=es
43. IMSS. Importancia de la lactancia materna [Internet]. Gob.mx. [citado el 10 de agosto de 2022]. https://www.imss.gob.mx/_maternidad2/eres-mama/lactancia-materna
44. Salazar Scarlet, Chávez Mervin, Delgado Xiomara, Eudis Rubio Tamara Pacheco. lactancia materna Arco Venez Puer Ped [Internet]. 2009 Dic [citado 2022 Ago 02] ; 72(4): 163-166. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06492009000400010&lng=es.
45. MINSA. Más Salud. <http://bvs.minsa.gob.pe/massalud/MasSalud02.pdf> (Ultimo acceso 08 de agosto del 2022)
46. Urquiza R. Lactancia materna exclusiva: ¿siempre? Rvdo. Turquí ginecólogo obstetra [Internet]. abril de 2014 [citado el 8 de agosto de 2022]; 60(2): 171-176. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322014000200011&lng=es
47. UNICEF. Guía familiar de lactancia materna y alimentación complementaria [Internet]. Unicef.org. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.unicef.org/panama/media/2636/file/LACTANCIA%20MATERNA%20GU%C3%8DA%20.pdf>
48. Técnicas de Lactancia Materna – AEP – Lactancia Materna [Internet]. AEP - Lactancia Materna. 2022 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <http://lactanciamaterna.aeped.es/tecnicas-de-lactancia-materna/>

49. Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano” [Internet]. Gob.mx. [citado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/node/94951>
50. Organización Mundial de la Salud. La alimentación del lactante y del niño pequeño. Washington. Editorial OMS, OPS. 2010
51. Estrada C. Cómo es la evolución y el desarrollo del bebé de 0 a 6 meses [Internet]. Guiainfantil.com. Guiainfantil.com; 2020 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.guiainfantil.com/bebes/etapas/como-es-la-evolucion-y-el-desarrollo-del-bebe-de-0-a-6-meses/#header0>
52. Stanford Medicine Children’s Health [Internet]. Stanfordchildrens.org. 2019 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=newborn-reflexes-90-P05741#:~:text=Este%20reflejo%20se%20produce%20cuando,dura%20alrededor%20de%20cuatro%20meses>
53. ¿Qué rol cumple la enfermería en la promoción de la lactancia materna? [Internet]. Corporación Universitaria Iberoamericana. 2020 [citado el 9 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.iberu.edu.co/2020/08/06/que-rol-cumple-la-enfermeria-en-la-promocion-de-la-lactancia-materna/#:~:text=El%20papel%20que%20desempe%C3%B1a%20el,con%20alimentos%20hasta%20los%20dos>
54. Alvarado Laura, Guarín Luzmila, Cañón-Montañez Wilson. Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo: reporte de caso en la Unidad Materno Infantil. RevCuid [Internet]. enero de 2011 [citado el 8 de agosto de 2022]; 2(1): 195-201. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732011000100015&lng=en.
55. Conocimiento [Internet]. Enciclopedia Significados. 2014 [citado el 14 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.significados.com/conocimiento/>
56. Porto JP. Niveles [Internet]. Definición.de. Definicion.de; 2008 [citado el 14 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://definicion.de/niveles/>
57. Columbié M., Morasen E., Daudinot B., Pría M., Moya Y., Couturejuzón L. Instrumento para explorar nivel de conocimientos sobre seguridad del paciente en estudiantes de pregrado. Educ Med Super [Internet]. 2016 Jun [citado 2024 Feb 19] ; 30(2). Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000200009&lng=es.

58. Hernández R., Fernández C., Baptista M. Metodología de la investigación. [Internet]. México: Mac Graw Hill; 2014 [citado 12 de febrero del 2024]. Disponible en: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
59. Koepsell D., Ruiz M. Ética de la investigación, Integridad Científica. 1º Edición. [Internet]. México: CONBIOÉTICA; 2015 [citado 12 de febrero del 2024]. Disponible en: https://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/Libro_Etica_de_la_Investigacion_gratuito.pdf

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Título: Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres que acuden a un Centro de Salud, Lima - 2024

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
GENERAL: ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden al Centro de Salud Zárate, Lima - 2024?	GENERAL: - Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden al Centro de Salud Zárate, Lima – 2024 ESPECÍFICOS: - Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión aspectos generales en madres que acuden al Centro de Salud Zárate. - Identificar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en la dimensión técnica de amamantamiento en madres que acuden al Centro de Salud Zárate.	No requiere hipótesis, porque es un estudio descriptivo	Nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es la información personalizada y subjetiva sobre cuándo y cómo alimentar exclusivamente desde el seno de la madre al lactante, sin tener que introducir líquidos o comida sólida durante los primeros seis meses de vida; debido a que, en este periodo, la leche materna contiene todos los macro y micronutrientes necesarios que su organismo necesita para su crecimiento idóneo.	TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo transversal DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental	POBLACIÓN: La población estará conformada por todas las madres que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, y que asisten al Centro de Salud Zárate, para los servicios de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED) y la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI). MUESTRA: No habrá muestra ya que se considerará a toda la población en estudio según criterios de inclusión y exclusión. Se obtendrá el total de madres a través del muestreo no probabilístico por conveniencia.

ANEXO 2: INSTRUMENTO CUESTIONARIO

PRESENTACIÓN:

Estimada madre de familia, mi nombre es Sol Venus Rodríguez Vela, estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y estoy realizando un estudio de investigación titulado **“Nivel de Conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños que acuden a un Centro de Salud de Lima, 2024”**, la cual permitirá brindar una mayor información sobre la realidad en la que se encuentran las madres actualmente, y de esa manera contribuir mediante la promoción de la salud con la finalidad de reflejar un crecimiento y desarrollo óptimo en los lactantes. Por tal motivo, la invito a participar de este cuestionario que será de carácter anónimo y confidencial, solo para uso del estudio, por lo que solicito responda con total sinceridad. Se agradece de antemano su colaboración.

INSTRUCCIONES:

Realice la lectura de cada una de las preguntas y responda con letra clara o marque con un aspa (X) la alternativa que considere conveniente. Es importante que responda todas las preguntas, y si presenta alguna duda puede solicitar mi ayuda.

CONTENIDO:

A. DATOS GENERALES:

De la madre:

1. Edad: 18 – 23 años (A)
24 – 29 años (B)
30 – 35 años (C)
36 – 41 años (D)
2. Grado de instrucción:
Ninguno (A) Primaria (B) Secundaria(C)
Técnica (D) Universitaria (E)
3. Estado Civil:

Casada (A) Soltera(B) Conviviente (C)

Viuda (D) Divorciada (E)

4. Ocupación: Ama de casa (A) otros (B)

5. Número de hijos en total:

1 (A) 2 (B) 3 (C) 4 o más (D)

6. Tipo de alimentación del niño(a):

Lactancia exclusiva (A) Lactancia mixta (B) Solo fórmula láctea (C)

Del bebé:

1. Edad del niño:

(A) 0 a 1 mes

(B) 1 mes 1 día a 2 meses

(C) 2 meses 1 día a 3 meses

(D) 3 meses 1 día a 4 meses

(E) 4 meses 1 día a 5 meses

(F) 5 meses 1 día a 6 meses

2. Sexo: Femenino (A) Masculino (B)

B. DATOS ESPECÍFICOS: A continuación, marque con un aspa (X) las respuestas a las siguientes preguntas que presentan opción múltiple, es importante que solo marque una sola alternativa.

1. La lactancia materna exclusiva consiste en darle al niño(a):

- a. Leche materna y papilla
- b. Leche materna y sopas
- c. Leche materna y agua
- d. Sólo leche materna

2. La lactancia materna exclusiva se brinda al niño(a) hasta los primeros:

- a. 2 meses de vida.
- b. 3 meses de vida.
- c. 6 meses de vida.
- d. 5 meses de vida.

3. La lactancia materna se inicia por primera vez:

- a. Después de 2 horas del nacimiento

- b. Durante la primera hora de vida
- c. Un día después del nacimiento
- d. Después de 3h del nacimiento

4. La primera leche producida por la madre es conocida como calostro, la cual ayuda al bebé en:

- a. La eliminación del meconio (primera deposición)
- b. Elevar el sistema inmunológico
- c. Que acepte más rápido la leche materna
- d. Generar un mayor vínculo con su madre

5. La lactancia materna exclusiva es importante porque:

- a. Es una de las formas para alimentar al niño(a) junto a la fórmula láctea
- b. Brinda los nutrientes esenciales y la hidratación necesaria para su desarrollo óptimo
- c. Lo alimenta por 1 año entero sin necesidad de brindar otros alimentos
- d. Lo ayuda sólo a su crecimiento físico

6. Los tipos de leche materna que existen son:

- a. Calostro y leche madura
- b. Leche de transición y leche madura
- c. Calostro y leche de transición
- d. Calostro, leche de transición y leche madura

7. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva al niño(a) son:

- a. Favorece su adecuado crecimiento y desarrollo, y lo protege de enfermedades crónicas.
- b. Fortalece solo su sistema excretor y es gratis.
- c. Favorece el vínculo padre-hijo y reduce el riesgo de sufrir osteoporosis
- d. Duerme con más rapidez, más tiempo y permite a la madre realizar otras actividades.

8. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la madre son:

- a. Ayuda en la recuperación después del parto y disminuye la posibilidad de contraer enfermedades crónicas no transmisibles

- b. Sirve como anticonceptivo natural y a la involución más rápida del útero
- c. Reduce la incidencia de hemorragias postparto y ayuda a la subida del peso corporal.
- d. Es gratis y ayuda a la prevención del cáncer de estómago.

9. Los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva a la familia, además de ser económica, permite:

- a. Reducir el riesgo de padecer VIH.
- b. Su disponibilidad inmediata
- c. Disminuye la muerte de niños(as) menores de 2 años.
- d. No contaminar el medio ambiente.

10. Antes de dar de lactar, lo primero que usted tiene que hacer como medida higiénica es:

- a. Amarrarse el cabello
- b. Bañarse
- c. Cambiarse de ropa
- d. Lavarse las manos con agua y jabón

11. El reflejo de búsqueda se refiere cuando el niño(a):

- a. Lleva su mano a la boca
- b. Mueve la cabeza y abre la boca para buscar en dirección al seno de la madre
- c. Siente que se le toca la palma de la mano y la cierra inmediatamente
- d. Se ríe al tocarle suavemente las mejillas

12. Cuando se le da de lactar al niño, la madre debe coger su seno en forma de:



a.



b)

13. La posición que debe adoptar la madre al amamantar además de ser cómoda y relajada, debe colocar la cabeza del niño sobre:

- a. La flexión de su codo
- b. El antebrazo
- c. Todo el brazo
- d. Las piernas

14. La posición que un niño(a) debe optar cuando es amamantado, además de estar pegado a la madre, debe coger con su boca:

- a. La mitad del pezón.
- b. El pezón y gran parte de la areola.
- c. La punta del pezón
- d. Toda la areola

15. Marque la imagen que usted considere que tiene un buen agarre del seno materno:



a.



b)

16. La succión del niño(a) es considerada adecuada, cuando las mamadas son:

- a. Lentas, profundas y con pausas cortas
- b. Rápidas, profundas y con pausa
- c. Lentas, superficiales y con pausas prolongadas
- d. Rápidas, profundas y sin pausas

17. Una succión adecuada también se puede observar cuando el niño presenta:

- a. Mejillas tensas, mentón del bebé en el aire y labio inferior evertido

- b. Labio inferior evertido, mentón del bebé tocando el seno materno y boca media abierta
- c. Labio inferior evertido, mejillas redondeadas y boca bien abierta
- d. Mejillas redondeadas, mentón del bebé en el aire y labio inferior evertido

18. Cuando el niño no tiene un buen agarre, los senos de la madre pueden sufrir:

- a. Abultamiento de leche
- b. Raspones en todo el seno materno
- c. Grietas o heridas en el pezón
- d. Moretones alrededor del pezón
- e. Vaciamiento de leche materno

19. Se debe amamantar al niño(a) de cada: (rango de tiempo)

- a. 3 a 5 minutos
- b. 20 a 30 minutos
- c. 2 a 3 horas
- d. 5 a 6 horas

20. Se debe amamantar al niño(a) cada vez que: (situación o momento)

- a. Lloro
- b. Se despierta
- c. No hay momento determinado (libre demanda)
- d. Se acuerda

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN...!

ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Consentimiento Informado

Proyecto de tesis: “Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres que acuden a un Centro de Salud, Lima - 2024”.

Yo, Identificada con DNI N° por medio de la presente expreso libre y voluntariamente, sin ningún tipo de presión de por medio, que acepto participar en el proyecto de tesis conducido por Sol Venus Rodriguez Vela y autorizada por la Facultad de Medicina y Escuela de Enfermería, así como del respaldo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Comprendo que el objetivo de la investigación es Determinar los conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres que acuden al Centro de Salud Zárate, Lima – 2024. Además, que la realización del cuestionario tomará alrededor de 15min, y que si no aceptara mi participación nadie me tratará de manera diferente. Comprendo que mi participación es totalmente voluntaria, y que, si deseo, puedo retirarme en cualquier momento. Asimismo, se me ha explicado que las respuestas al cuestionario son de carácter confidencial y que nadie tendrá acceso a ellas, mis datos personales también se mantendrán confidenciales. Por otro lado, participar en el estudio no costará nada, ni recibiré ningún estipendio y que si tuviera alguna pregunta podré llamar a la responsable del estudio. He leído y entiendo este consentimiento informado.

Firma de la madre de familia

ANEXO 5: INFORME DE JUICIOS DE EXPERTOS

Item	J1	J2	J3	J4	Σ	Mx	CVCi	Pei	CVCic
1	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
2	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
3	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
4	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
5	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
6	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
7	4	4	5	3	16	4,0000	0,8000	0,0039	0,7961
8	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
9	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
10	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
11	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
12	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
13	3	4	5	5	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
14	4	4	5	4	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
15	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
16	4	4	5	4	17	4,2500	0,8500	0,0039	0,8461
17	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
18	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
19	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
20	4	4	5	5	18	4,5000	0,9000	0,0039	0,8961
									17,6719
								CVCT	0,88359375
								CVC tc	0,8797

Durante el análisis que realizaron los expertos, sugirieron algunos cambios del texto, que se tuvieron en consideración para la elaboración del instrumento final.

ANEXO 6: LIBRO DE CÓDIGOS

Datos generales:

De la madre:

CRITERIO	CATEGORÍA	CÓDIGO
1. Edad	18 – 23 años	A
	24 – 29 años	B
	30 – 35 años	C
	36 – a más años	D
2. Grado de instrucción	Ninguno	A
	Primaria	B
	Secundaria	C
	Técnica	D
	Universitaria	E
3. Estado Civil	Casada	A
	Soltera	B
	Conviviente	C
	Viuda	D
	Divorciada	E
4. Ocupación	Ama de casa	A
	Otros	B
5. N° de hijos en total	Uno	A
	Dos	B
	Tres	C
	Cuatro o más	D
6. Tipo de alimentación del niño(a)	Lactancia materna exclusiva	A
	Lactancia mixta	B
	Sólo fórmula láctea	C

Del niño(a):

CRITERIO	CATEGORÍA	CÓDIGO
1. Edad	0 a 1 mes	A
	1 mes 1 día a 2 meses	B
	2 meses 1 día a 3 meses	C
	3 meses 1 día a 4 meses	D
	4 meses 1 día a 5 meses	E
	5 meses 1 día a 6 meses	F
2. Sexo	Femenino	A
	Masculino	B

Datos específicos:

Cuestionario:

VALOR O CATEGORÍA	CÓDIGO
Respuesta correcta	1
Respuesta incorrecta	0

Nº de ÍTEM	Clave	Puntaje
1	d	1
2	c	1
3	b	1
4	b	1
5	b	1
6	d	1
7	a	1
8	a	1
9	b	1
10	d	1
11	b	1
12	b	1
13	a	1
14	b	1
15	a	1

16	a	1
17	c	1
18	c	1
19	c	1
20	c	1

